



МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ П.А. ГЕРЦЕНА

ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ РАДИОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ

125284, г. Москва, 2-й Боткинский пр., д. 3

+7 (495) 150-11-22



ПРОТОКОЛ ПЭТ/КТ

от 04.06.2025 09:00

ПоликГерц

Мишин Александр Валентинович (М), 13.12.1961 / 63

МК 1-2023/29237

Срочность: Плановое

Кабинет: [И] ПЭТ КТ - ПСМА

Тип оплаты: ОМС

Цель исследования: Диагностика

Код МКБ: С61 Рак предстательной железы рТ3bN1M0 Стадия IV. Состояние после хирургического лечения: лапароскопическая радикальная простатэктомия, расширенная тазовая лимфаденэктомия 26.09.2023 г. Состояние после гормональной терапии аЛГРГ с 10.2023г. по 04.2024г. Прогрессирование 05.2025г, рТ3bN1M0, стадия IV, без стадии

ПРОВЕДЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

04.06.2025 09:00 – 04.06.2025 09:30 (30 мин.)

1) ПЭТ/КТ всего тела.

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Аппарат: GE Discovery IQ 5r

Расходные материалы

Название расходного материала	Ед.изм.	Кол-во
[18F]ПСМА-1007	MBq	446
Омнипак	мл	130
Фуросемид	мг	10

ПРОТОКОЛ

Определяется физиологически повышенное накопление РФП в слизистой оболочке носовой полости, лимфоузловом кольце, слезных и слюнных железах, паренхиме печени, селезенки, поджелудочной железы, почек, желчевыводящих и мочевыводящих путях, в стенках тонкой и толстой кишки.

Патологическая гиперфиксация РФП определяется в:

- гипervasкулярном узлом образования, расположенном спереди и справа от цистоуретрального анастомоза, тесно прилежащего спереди к лонному сочленению (без признаков контактной деструкции костной ткани), сзади – к шейке мочевого пузыря и уретре (вероятно, с инвазией в мочевой пузырь), общими размерами 41x25мм и SUVmax 42,2;
- множественных измененных тазовых лимфатических узлах (в мезоректальной клетчатке с двух сторон, пресакрально, паравезикальные, внутренние подвздошные с обеих сторон, запирающие справа), имеющих сливной характер на уровне запирающей области справа; глубоком паховом слева; таргетно: запирающий справа до 15мм по КО с SUVmax 26,7; паховый слева, размерами до 6мм по КО с SUVmax 22,8;
- единичных очагах слабоинтенсивного склероза в костях: в левой половине тела Th6 размером 11мм с SUVmax 18,67, в правой седалищной кости с SUVmax 7,84, размером 5мм.

Лобная пазуха слева и ячейки решетчатого лабиринта заполнены густым содержимым. Пневматизация обеих сосцевидных отростков височных костей снижена.

В легких очаги уплотнения до 3мм - изменения поствоспалительного характера. Паратрахеально слева, в корне левого легкого визуализируются единичные лимфоузлы с фоновым распределением РФП размером по КО до 9мм.

Липоматоз поджелудочной железы. Определяется неравномерное утолщение левого надпочечника на уровне тела и медиальной ножки, правого надпочечника на уровне медиальной ножки до 10мм, без патологически повышенного накопления РФП. Единичные паравезикальные кисты в правой почке.

Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника.

Атеросклероз аорты и ее крупных ветвей.

На остальном протяжении – картина без особенностей.

